



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 12-06-2024 13:49:23

Página 1 de 4

Información Paciente			N° Epicrisis	
Nombre	: Amelia Del Carmen Araya Ruiz	Rut	: 9.169.387-9	N° Archivo : 2414988
Edad	: 64a 0m 9d	Fecha Nacto:	03/06/1960	Sexo : Femenino
Dirección	: Pob Argentina Solidaridad 132	Comuna	: Quilpue	Teléfono : 1 2345 6789

Información Hospitalización				Días Estadía: 8	
Unidad de Ingreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Ingreso	: 04/06/2024	13:22	
Unidad de Egreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso	: 12/06/2024	13:06	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso
Daño hepático crónico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiologia

Resumen Clínico

EGRESO UCI F

Nombre Amelia Araya Ruiz
Edad 63
Sexo Femenino Fecha nacimiento 03.06.1960
Actividad Comerciante. Previsión Fonasa D
RUT 9169387-9 Ficha 76.615
Dirección Calle Solidaridad 0132-B Quilpué

Fecha ingreso Hospital Quilpué 29.05.24 Hora: 14:01
Fecha ingreso UPC Quilpué 31.05.24 Hora: 22:30
Fecga Ingreso UCI CASR 04.06.24
Motivo de ingreso Insuficiencia hepática.

Antecedentes mórbidos previos DHC NO OH, etiología no filiada. HTA
Alergias No
Farmacos Rifaximina furosemida omeprazol espironolactona propanolol enalapril acido ursodesoxicólico
Hábitos No refiere
Tabaco No refiere
Alcohol No refiere
Cirugías previas Colectomía.
Estado funcional previo Autovalente, trabaja.
RAM a fármacos No descrito.
Vacunas No descrito.

HISTORIA ACTUAL:
Paciente con historia de DHC desde el año 2015, con controles esporádicos en red privada sin gastroenterólogo/a tratante. Familia desconoce estudios en específico. Ingresó el día 29/05/2024 derivada desde hospital de Peñablanca, donde se encontraba hospitalizada por cuadro de compromiso cuali-cuantitativo de conciencia de aprox una semana de evolución. Refieren hospitalización reciente hace 3 semanas por encefalopatía hepática en clínica privada, de alta con manejo por DHC.

Fecha Epicrisis : 12/06/2024 13:49

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:00

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 12-06-2024 13:49:23

Página 2 de 4

En exámenes de ingreso 29/05 Bbt 17.85 dir 13.62 amonio 11, INR 2.58, creatinina 1.3 Na 120 K 4.8 albumina 2.0 Hb 11.4 plaquetas 74000 GB 10160. Con encefalopatía grado II y ausencia de deposiciones, sin sangrado ni signos de PBE. Se inició manejo con albumina, Rifaximina y laxantes osmóticos. Se solicita TC TAP 30/05 a las 01:03 que informa DHC con ascitis moderada, ectasia de vías biliares intra y extrahepáticas, signos de duodenitis, engrosamiento parietal colonico y Ateromatosis aorto-iliaca. En torax infiltrado intersticial de aspecto congestivo. Paciente es evaluada inicialmente por UPC 29/05, definen sin criterios de ingreso en ese momento.

Se optimiza manejo durante el día 30/05 y se presenta nuevamente caso a UPC, que definen con requerimiento de ingreso UTI, sin disponibilidad de camas, por lo que indican externalizar via UGCC.

Paciente durante el día 31/05 cursa con mayor deterioro, con encefalopatía grado III, requerimientos de O2 hasta FiO2 50%, mala mecánica ventilatoria, por lo que se decide IOT y soporte en UCI.

En exámenes, deterioro progresivo de función hepática. Lab ingreso UCI H. Quilpué: láctico 1.67mmol/L, creatinina 1.1 BUN 31 Na 125 K 4.6 PCR 19.6 INR 2.58->4.89 TTPK incoagulable pH 7.44 pCO2 30 HCO3 20 pO2 115 FiO2 30% GOT 190 GPT 119 FA 180 GGTP 99 Bilirrubina total 17.85->26.65 directa 19.65 Hb 8.1 plaquetas 74.000->46.000. Col Tot <30, albumina 2.0. Ferritina 2690.

EVOLUCION EN UCI H. QUILPUÉ

Se mantuvo en UCI del H. Quilpué con soporte en VM, en SAS 1 con midazolam porque con fentanilo presentaba bradicardia 40-45x_g, sin mayor conflicto en mecánica ventilatoria ni intercambio.

Durante el 31.05 la describen con altas dosis de vasoactivos (no especifican números) y AKI KDIGO III, anúrica, BUN hasta 37, crea 1.3. Deciden iniciar TRR de agudos, completando 48 hrs el 03.06 (HFAV 50 ml/kg), con reducción de vasoactivos, quedando con noradrenalina a dosis de 0.08mcg/kg/min para PAM 65, además, infusión continua de albumina al 20%.

Por otro lado, presentó caída de Hb/hcto desde el 30.05 progresivamente (desde 9.1 a 6.1) con plaquetopenia (de 70mil a 18mil). Sin HDA evidente. Múltiples equimosis en sitios de punciones de CVC y LA. Necesitó transfusión de 2 UGR y 7 U de plaquetas, sin EDA realizada en Quilpué.

En lo infeccioso, recibiendo ceftriaxona por posible broncoaspiración en contexto de encefalopatía, sin episodios febriles durante la estadía, sin clínica de PBE ni ascitis visualizable en eco para estudio, hemocultivos aerobios I-II 30/05 negativos a la fecha del traslado a UCI CASR.

En lo hepático, progresión de hiperbilirrubinemia hasta 34 sin componente obstructivo y transaminasas en lenta disminución, coagulopatía intensa, INR 4.89 y TTPa incoagulable.

Estudio etiológico: VHB VHC VIH no reactivos, IgA-M-G en rango normal, Ac ANA negativos, AFP 0.744 normal.

Se presenta caso a comité de trasplante asignado (hospital Sótero del Río), planteando traslado a CASR para continuar manejo.

Ingresa a UCI CASR estable dentro de su gravedad, en VMI, quedando en VCV, VT 400, peep 8, fio2 0.45, con NAD a 0.1 y midazolam a 0.04 en SAS 2-3

EXAMEN FÍSICO INGRESO UCI

PA 111/44, PAM 72, FR 26, T 32.2, SAT 96, FIO2 0.45, FC 46-50x_g

Pupilas isocóricas reactivas, llene capilar 2seg, sigue 1/5 órdenes,

Edema de EE +++, múltiples equimosis en sitios de punción, CHD/YD in situ, CVC YI 3L in situ

Cardíaco RR2T, SS

Pulmonar MP+ disminuido en bases, crepitaciones bibasales

Abdomen: BD, sin ascitis clínica, RHA-

EEII edema ++/++, flictena EID, pulsos presentes, sin empastamiento

DIAGNOSTICOS DE INGRESO UCI

1. Insuficiencia hepática aguda sobre crónica
 - a. Meld Na 38 (65% mortalidad 90 días)
 - b. CLIF-C ACLF 71 puntos.
2. DHC de etiología no precisada, no OH.
3. Anemia aguda severa recuperada
-HDA vs sangrado sitios de punción
4. AKI KDIGO III multifactorial
-Obs sd hepatorenal

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS

Hemodinámico/renal: desde ingreso con requerimientos de NAD a dosis altas para lograr PAM objetivo. Ecocardiografía sin disfunción valvular o cardíaca severa, como hallazgo se encontró shunt intra cardíaco dado test de burbuja positivo precozmente.

Durante estadía recibió soporte con diálisis continua para estabilidad hemodinámica, sin embargo nunca logró destete de drogas vasoactivas.

Respiratorio: durante estadía evolucionó con SDRA con requerimiento de BNM, que se interpretó inicialmente como sobrecarga de volumen. Sin embargo no hubo mejoría significativa a pesar de BH negativos y terapias de reemplazo renal.

Infeccioso: pancultivada, en hemocultivos se aisló Staphylococo coagulasa negativo, recibiendo terapia con vancomicina. En contexto de gravedad se agregó imipenem para cobertura de gram negativos.

Hepático: paciente con ACLF, durante estadía en seguimiento diario por equipo. Sin embargo, nunca logró estabilidad clínica para alcanzar ventana para enlistarse para trasplante.

Paciente evoluciona con falla orgánica múltiple, falleciendo el día 12/06 a las 11:30 acompañada de su esposo. Se realizó entrega de certificado de defunción.

DIAGNOSTICOS DE EGRESO UCI

1. Insuficiencia hepática aguda sobre crónica
 - a. Meld Na 38 (65% mortalidad 90 días)
 - b. CLIF-C ACLF 71 puntos.
2. DHC de etiología no precisada, no OH.
3. Bacteremia por stafilococo coagulasa negativo
4. Anemia aguda severa recuperada
-HDA vs sangrado sitios de punción
5. AKI KDIGO III multifactorial
-Obs sd hepatorenal

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia hepática aguda -

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Fecha Epicrisis : 12/06/2024 13:49



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 12-06-2024 13:49:23

Página 4 de 4

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Bec. Víctor Alejandro Vidal Zamor

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 12/06/2024 13:49

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:00

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar